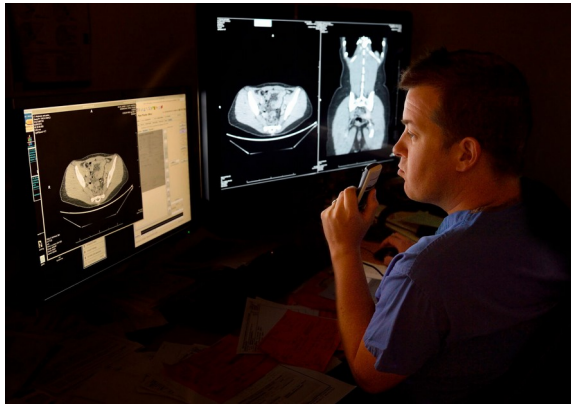
Две стороны приёма: врач и пациент



Врач



Пациент

Без модели Врач → Решение → Пациент

С моделью Врач → Модель → Решение → Пациент

Модель встаёт не рядом с приёмом, а внутри него

У приёма две стороны: у врача мерили поведение на задаче, у пациента — согласие с решением, и это разные предметы измерения.

Полная запись источников

Влияние на врача

Якорение

Заключение врача сдвигается к подсказке модели, даже заведомо неверной: 23,6 против 92,8 из ста, 220 врачей.

Сужение

Там, где модель молчит, взгляд врача реже задерживается — пропущено 61 против 29 из ста, 10 врачей.

Износ навыка

Привыкнув к модели, врач без неё находит меньше: 22,4 против 28,4 из ста, 1 443 процедуры.

Поток тревог

Модель шлёт тревоги потоком, и врач отклоняет почти все подряд — 90 из ста, из высшей тяжести лишь 0,5.

Несогласие

Расхождение с моделью разбирают отдельным шагом: 3 449 арбитражей без модели против 5 283 с ней, на 50 000 женщин.

Поправка

Здесь наоборот: врач переписывает заключение модели, если находит ошибку — 31 из ста, 159 630 кардиограмм.

Предупредить не помогает — помогают только действия человека во время работы с моделью или после неё.

Полная запись источников · *медицинские замеры*

Влияние на пациента

Раскрытие

Когда пациенту говорят, что врач пользуется моделью, доверие к врачу падает: 0,30 против 0,63 у 1 762 взрослых.

Одиночество

Модель как единственного читателя снимка почти не принимают, а как второе мнение — охотно: 23 против 368 из 518.

Асимметрия

Если тревогу поднимает модель — 319 из 359 просят проверки врача; если тревогу поднимает врач — лишь 184 из 359 просят проверки модели.

Цена

Когда осмотр моделью бесплатен, её выбирают заметно чаще — 81 против 43 из ста, 248 взрослых.

Безымянность

Без подписи автора ответ модели кажется более сочувственным, чем ответ врача: 4,11 против 2,01 из пяти, 45 человек.

Пациент принимает модель помощником и отвергает исполнителем.

Возраст и образование этого не объясняют. Затухания доверия во времени не измерено нигде.

Полная запись источников